

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA — EMERGENCIA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Emergencia Gineco-Obstétrica

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	25 años
Estado civil:	Conviviente
Ocupación:	Vendedora
Fecha de ingreso:	15/03/2026 08:45

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G1 P0. Primigesta. Niega antecedentes patológicos relevantes ni cirugía cervical.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	01/09/2025
FPP:	08/06/2026
EG actual (por FUM):	28 semanas
Motivo de ingreso:	Amenaza de parto prematuro
Tiempo de evolución:	6 horas

Paciente refiere contracciones uterinas regulares (4 en 30 minutos) desde hace 6 horas. Niega sangrado vaginal o pérdida de líquido. Movimientos fetales presentes y normales. Refiere haber realizado esfuerzo físico el día previo.

EXAMEN FÍSICO AL INGRESO

PA 110/70 mmHg. FC 88 lpm. T° 36.7°C (afebril). Peso 62.0 kg. AU 26 cm. LCF 148 lpm. Dinámica uterina: 3-4 contracciones en 10 min, intensidad moderada, duración 30-40 segundos. Tacto vaginal: cuello posterior, cerrado, sin modificaciones cervicales.

EXÁMENES DE INGRESO (15/03/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	11.4	g/dL	Dentro de rango
Leucocitos	10200	/mm³	Limítrofe alto
PCR	0.6	mg/dL	No elevada
Test fibronectina	Negativo	—	Bajo riesgo parto en 14 días
Urocultivo	Pendiente	—	Tomado al ingreso

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

1. Embarazo de 28 semanas por FUM. 2. Amenaza de parto prematuro sin modificaciones cervicales. 3. Test de fibronectina negativo (bajo riesgo de parto en próximos 14 días).

PLAN

1. Hospitalización en sala obstétrica por 24-48 horas para observación. 2. Tocolítico de primera línea (nifedipino 20 mg VO de carga, luego 10 mg c/6 h). 3. Maduración pulmonar fetal con betametasona 12 mg IM c/24 h x 2 dosis. 4. Reposo en cama. Hidratación IV. 5. Monitoreo materno (PA, FC, dinámica uterina c/2 h) y fetal (NST diario). 6. Alta condicionada a cese de dinámica uterina y sin modificaciones cervicales.